

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	腹膜透析腹膜炎 Peritoneal Dialysis Peritonitis				
編號	A31000-Q03-W-E08	制定者	HD 林卉嫻	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.1 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解腹膜透析腹膜炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，進而有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

腹膜透析病人若有符合下列任兩項條件，即可診斷為腹膜炎：

1. 有臨床症狀：腹膜透析引流液混濁或腹痛。
2. 腹膜透析液檢測：白血球 $>100/\mu\text{l}$ 且多核白血球 $>50\%$ （採檢的引流液必須留置腹內 >2 小時）。
3. 腹膜透析液之革蘭氏染色呈陽性或細菌培養有細菌。

（二）症狀與徵兆

1. 腹膜透析引流液混濁。
2. 上腹痛：是最常見的症狀。
3. 噁心及嘔吐：早期的腹膜炎症狀較不明顯，但隨著嚴重程度，嘔吐的症狀會越來越明顯。
4. 體溫變化：腹膜炎初期體溫可能在正常範圍，但隨著感染加劇或者菌血症的產生，體溫可能會逐漸上升。
5. 其他症狀：病人可能會感到非常虛弱、厭食、腸蠕動降低或腹脹，少數病人

主題名稱	腹膜透析腹膜炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E08	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/8

會有腹瀉的情形。

（三）常見檢查

1. 理學檢查：

(1)觸診：腹部會有壓痛及反彈痛，隨著感染加劇，則會出現腹部肌肉僵硬的現象。

(2)聽診：腸子蠕動聲下降，甚至聽不見。

(3)叩診：因腹部有脹氣現象，因此會有鼓音出現。

2. 實驗檢查：

腹膜透析引流液：白血球 >100 cells／ul、嗜中性白血球 $>50\%$ 。血液白血球數目增加、代謝性酸中毒、血液或腹膜透析引流液的培養出細菌。

3. 放射線檢查：

必要時行腹部 X 光檢查、腹部超音波或電腦斷層攝影，皆有助於腹膜炎的診斷。

（四）常見治療

1. 內科治療：

以抗生素腹腔內(IP)或靜脈注射(IV)給藥治療，最重要的是儘快找出引起腹膜炎的原因。

2. 外科治療：

對於內科治療無效者，則應考慮移除腹膜透析導管改為血液透析治療。

（五）護理問題

1. 易感染／腹膜感染。

2. 缺乏營養／少於身體所需。

3. 尋求（特定的）健康協助／腹膜透析相關技術及觀念錯誤。

4. 焦慮感受／對腹膜炎的治療無法掌握。

5. 疼痛不適／因腹膜炎產生的急性腹痛。

（六）護理措施

主題名稱	腹膜透析腹膜炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E08	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/8

1. 易感染／腹膜感染。

- (1) 依醫囑在透析液內加入抗生素治療(IP)，並觀察有無副作用，如：過敏。
- (2) 評估病人使用藥物治療後感染症狀改善的情形，包括：腹痛改善、引流液變清澈及引流液中的嗜中性白血球降低。
- (3) 持續追蹤透析液細菌培養報告。
- (4) 密切監測生命徵象，同時評估有無菌血症的產生。
- (5) 若依據細菌培養之藥物敏感試驗，使用有效抗生素治療 5 天以上仍未改善，應與醫師討論是否拔除腹膜透析導管改為血液透析治療。

2. 缺乏營養／少於身體所需。

- (1) 向病人解釋蛋白質流失的原因及補充蛋白質之重要性。
- (2) 衛教病人多攝取高效價蛋白質（動物性）食物，如：魚、肉、奶、蛋類並可採少量多餐的飲食方式。
- (3) 衛教病人每天蛋白質食物 1.2~1.3 公克/公斤，每餐均需有蛋白質食物並教導病人計算方法：一份蛋白質量為：魚或肉（熟食）三根手指大小厚度、全蛋一顆、蛋白二顆或牛奶 240ml。
- (4) 建議可補充透析配方牛奶來補充熱量及蛋白質。

3. 尋求（特定的）健康協助／腹膜透析相關技術及觀念錯誤

- (1) 說明導致腹膜炎的原因，提供衛教給予正確觀念並矯正其錯誤觀念。
- (2) 請病人執行腹膜透析換液技術並做評核，糾正錯誤的技術給予再教育，並重新評核至正確為止。
- (3) 提供病人預防腹膜炎的正確觀念並矯正其錯誤觀念。
- (4) 考核病人「腹膜炎相關知識及認知」，若未達滿分，給予再衛教並重新評核直到達滿分。

4. 焦慮感受／對腹膜炎的治療無法掌握

- (1) 鼓勵病人說出對腹膜炎的恐懼、焦慮及擔心的感覺。
- (2) 再次說明腹膜炎發生的原因、症狀、處置與預防方法等。

主題名稱	腹膜透析腹膜炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E08	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/8

(3)針對病人腹膜炎所產生的問題，給予適當的解釋及醫療處置。

(4)請有相同經驗的腎友將其經驗與病人分享其的治療歷程。

5. 疼痛不適／因腹膜炎產生的腹痛

(1)依醫囑連續沖洗三袋透析液，以減輕腹痛。

(2)以主動溫和的態度關懷病人，評估疼痛性質、頻率，必要時聯絡醫師給予止痛劑，並觀察使用後效果。

(3)適時表達關心，教導放鬆技巧，如戴耳機聽音樂及電台、使用智慧型手機看綜藝節目影片等等。

(七) 腹膜透析病人如何預防腹膜炎

1. 依照腹膜透析護理師所教導及訓練的標準換液步驟來進行。

2. 換液環境需緊閉門窗保持光亮及清潔。

3. 換液前要正確的洗手及戴口罩，換液時要專心，換液後應檢查引流液是否清澈。

4. 不可吃生食、生菜或飲用地下水。

5. 腹膜透析護理師視需要安排家庭訪視觀察透析環境及透析技術正確性。

6. 注意事項：

衛教病人若發現透析液混濁，請馬上電話聯絡腹膜透析室護理師，因為需要立即給予適當的治療以預防嚴重的合併症。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	腹膜透析腹膜炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E08	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/8

六、參考資料

- (一) 呂雅惠、詹瑞君、李英芬、李芸湘(2019)．運用 Watson 關懷理論照顧一位食道癌及結腸癌並存患者．長庚護理，30(1)，89-100。
- (二) 吳紅蓮(2017)．透析病人改善營養不良的重要性—營養諮詢與營養介入之應用．腎臟與透析，29(1)，49—53。
- (三) 郭麗雀、郭秋慧、陳靖博(2018)．互動式電子書對腹膜透析病人學習成效及生活品質之探討．腎臟與透析，17(1)，1-15。
- (四) 詹羽君、張簡綉雯、王筱珮(2022)．降低腹膜透析病人腹膜炎發生率改善專案．臺灣腎臟護理學會雜誌，20(2)，15-28。
- (五) 湯詠榆、黃心慈、林秀靜(2020)．運用醫療共享決策協助一位焦慮之透析治療病人的加護經驗．台大護理雜誌，16(1)，89—100。
- (六) Philip,T. L., , M. C., , C., , F., Tess, H., Talerngsak, K., Yong, L. K., et al. (2022) ISPD peritonitis guideline recommendations: 2022 update on prevention and treatment . doi: 10.1177/08968608221080586.

七、附件

(略)

主題名稱	腹膜透析腹膜炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E08	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	1. 修改說明內容。 2. 修改錯別字。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1. 將護理部改為護理部。 2. 修改說明中(一)定義的內容。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	參考資料文獻部份內容更新。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	3.3	1. 第三項說明內容部份刪修。 2. 第六項參考資料文獻更新。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	1. 第三項說明內容部份修辭。 2. 新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.5	1. 第三項說明內容文獻出處修改。 2. 第六項參考資料文獻更新。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.07.16	3.6	參考資料文獻部份內容更新。	

主題名稱	腹膜透析腹膜炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E08	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/8

修正日期	版本	修正說明	備註
107.09.12	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第六目之 1(4)參考資料修訂。 3. 第六項第七目新增。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.8	1. 第三項說明之第六及第七目部份內容及文獻出處修改。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項參考資料修訂。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.9	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	4.0	1. 第三項第一目部份內容修訂。 2. 第三項第五、六目護理問題修訂。 3. 參考資料文獻更新。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.10.26	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.10.15	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	4.1	1.第三項第一目第 2 點內容修訂。 2.第三項第六目第 1 點之(5)內容修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	腹膜透析腹膜炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E08	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註